

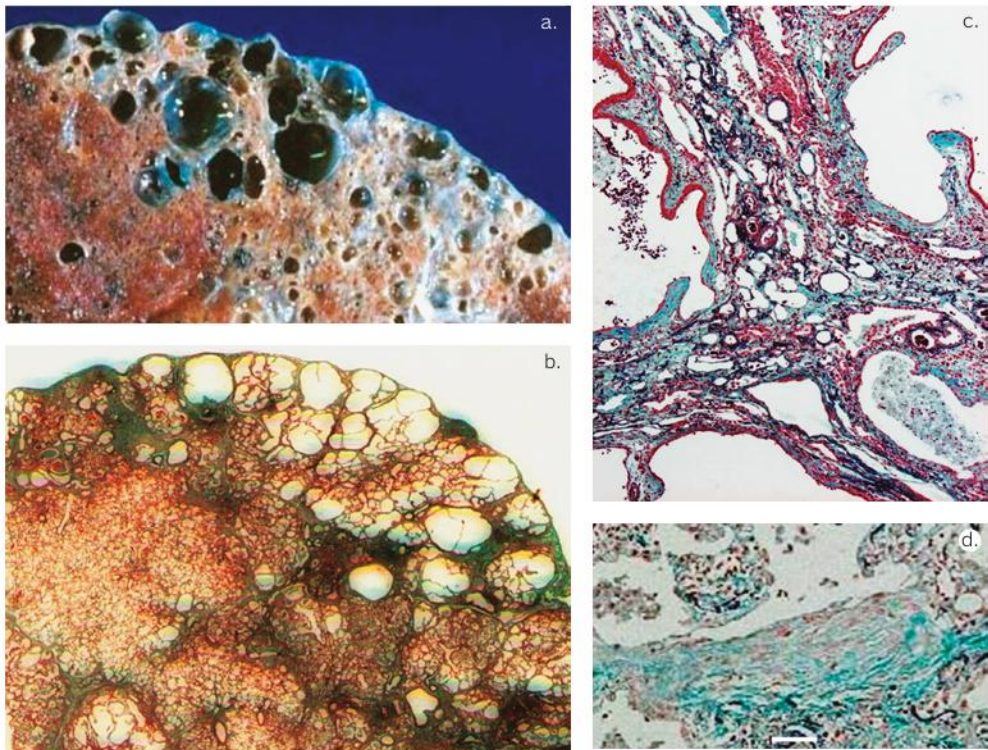


図4 IPF患者肺組織にみる蜂巣病変とUIPパターン

- a: 肉眼像でみる胸膜直下の蜂巣病変
 b: ルーペ図でみる蜂巣病変と小葉間隔壁の肥厚（UIPパターン）
 c: 蜂巣病変の間にみる肺胞虚脱像と線維芽細胞巣
 d: 線維芽細胞巣の拡大図（scale barは10μm）

表3 IPF 慢性安定期の治療

CQ	推奨文	推奨の強さ	エビデンスの強さ
CQ1: IPF患者にステロイド単独療法は推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してステロイド単独療法を行わないことを推奨する。	1	D (非常に低)
CQ2: IPF患者にステロイドと免疫抑制薬の併用療法は推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してステロイドと免疫抑制薬の併用療法を行わないことを推奨する。	1	C (低)
CQ3: IPF患者にN-アセチルシステイン（NAC）吸入の単独療法は推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してN-アセチルシステイン（NAC）吸入の単独療法を行わないことを提案する。	2	C (低)
CQ4: IPF患者にビルフェニドンは推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してビルフェニドンを投与することを提案する。	2	B (中)
CQ5: IPF患者にニンテダニブは推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してニンテダニブを投与することを提案する。	2	B (中)
CQ6: IPF患者にビルフェニドンとNAC吸入の併用療法は推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してビルフェニドンとNAC吸入の併用療法を行わないことを提案する。	2	B (中)
CQ7: IPF患者にビルフェニドンとニンテダニブの併用療法は推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対してビルフェニドンとニンテダニブの併用療法を行わないことを提案する。	2	D (非常に低)
CQ8-1: 安静時低酸素血症を伴うIPF患者に酸素療法は推奨されるか？	安静時低酸素血症を伴う慢性期のIPF患者に対して酸素療法を行うことを推奨する。	1	D (非常に低)
CQ8-2: 労作時低酸素血症を伴うIPF患者に酸素療法は推奨されるか？	労作時低酸素血症を伴う慢性期のIPF患者に対して酸素療法を行うことを提案する。	2	C (低)
CQ9: IPF患者に呼吸リハビリテーションは推奨されるか？	慢性期のIPF患者に対して呼吸リハビリテーションを行うことを提案する。	2	B (中)

[厚生労働科学研究費補助金難治性疾患政策事業「びまん性肺疾患に関する調査研究」班特発性肺線維症の治療ガイドライン作成委員会：特発性肺線維症の治療ガイドライン2023改訂第2版，南江堂，2023より作成]